



UMANDOK PENENTUAN INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS & UNIT TAHUN 2025



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Pasuruan, 02 Desember 2024

Nomor : 1341/RSPHS/I-UND/DIR/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Perumusan IMP-RS 2025

Kepada Yth.

1. PLT Wakil Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Keperawatan
3. Kepala Bidang Penunjang Medik
4. PLT Wakil Kepala Bidang Penunjang Medik
5. Kepala bidang umum dan keuangan
6. Seluruh Kepala Ruang / Unit / Instalasi
7. Seluruh Penanggung Jawab Program di Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa akan diadakan **Rapat Perumusan IMP-RS 2025** di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada :

Hari / tanggal : Rabu / 04 Desember 2024
Pukul : 08.30 - selesai
Tempat : Hall Andalusia Lt 3 RS Prima Husada Sukorejo
Kegiatan : **Rapat Perumusan IMP-RS 2025**

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

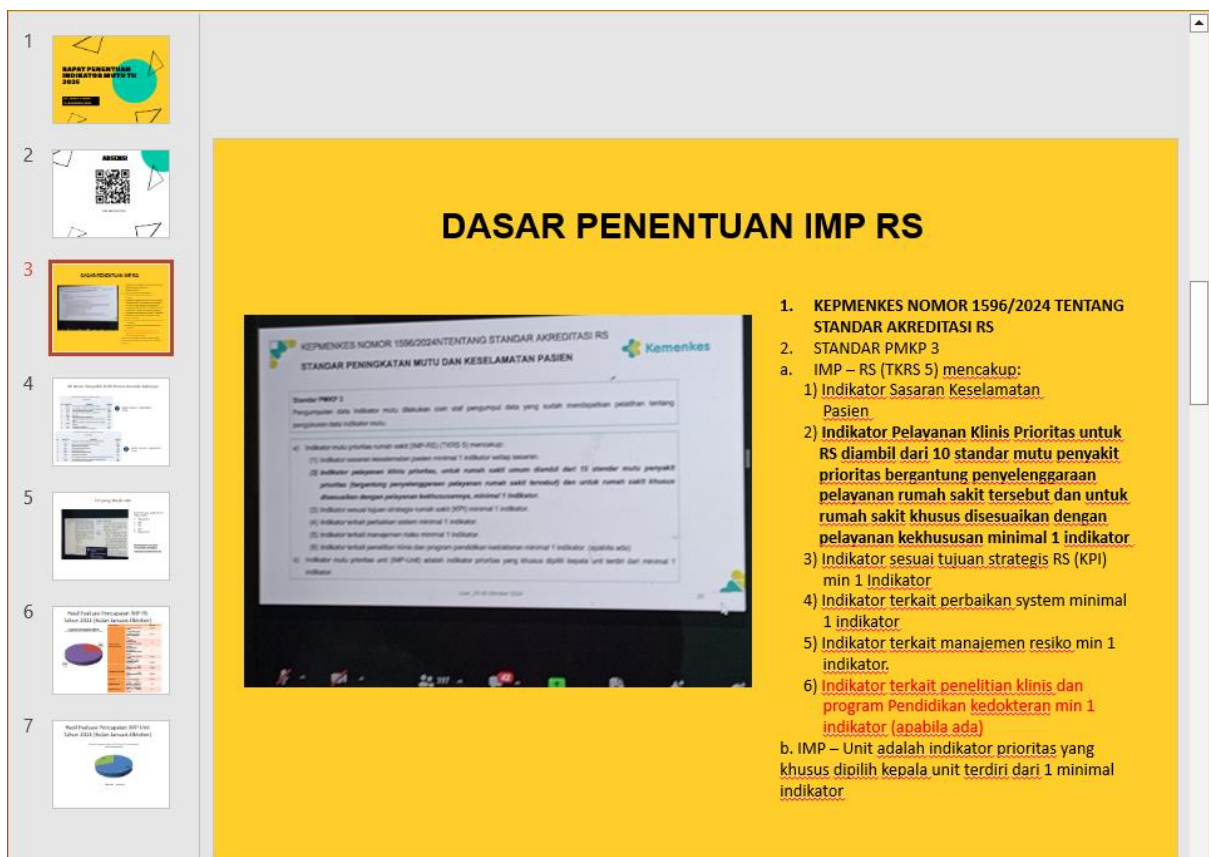
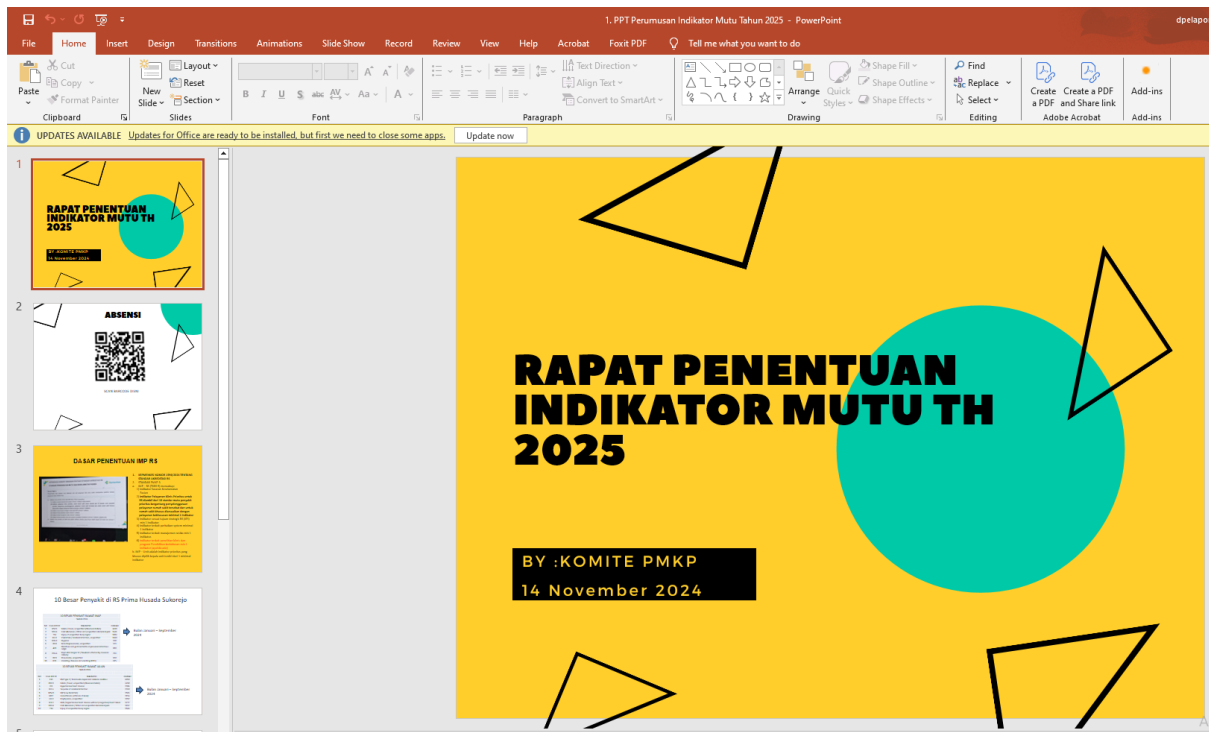
Hormat kami,
Direktur RS Prima Husada,



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS



MATERI





ABSENSI



RSPHSKR
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO, DESA LEMAHBANG KEC. SUKOREJO
KAB. PASURUAN
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Daftar Hadir RAPAT PEMBAHASAN IMP-RS 2025

Tempat : ANDALUSIA
Location

Tanggal dan : Rabu, 2024-12-04 08:30:00
Jam
Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Arindha Rahma Putri, S.Psi		administrasi	
2	Fernandika Bagus Setiawan	RS Prima Husada Sukorejo	CSSD	
3	apt Ramadhan Rizki P	RSPHSKR	Farmasi	
4	Rofi'atal Manzilah, S.Psi	RS Prima Husada Sukorejo	HRD / SDM	
5	Restu Kurniawati, S.KM	RSPHSKR	Kabid Umum	
6	Restu Kurniawati, S.KM	RSPHSKR	Kabid Umum	
7	Iilham Eka Novianto Putro, A.Md.Kep	RSPHSKR	Kepala Instalasi CSSD & Laundry RSPH Sukorejo	
8	Saila Nur Siti Khodijah, S.Gz	RSPHSKR	Kepala Instalasi Gizi & Dapur RSPH Sukorejo	
9	Fina Fitriana Dwi Nur, Amd.RMIK	RSPHSKR	Kepala Instalasi Rekam Medis & Pendaftaran RSPH Sukorejo	
10	Debi Firmanasia, Amd.Kep	RSPHSKR	Kepala Ruang ICU RSPH Sukorejo	
11	Angela Wensi Flora Rosa	RSPHSKR	Kepala Ruang IGD Umum RSPH Sukorejo	
12	Anis purnamasari	RSPHSKR	Kepala ruang irna 2A	
13	Bagas Surya Purwono, A.Md.Kep	RSPHSKR	Kepala Ruang IRNA 2B RSPH Sukorejo	
14	A. Kharimulloh Ikhwan, S.Kep.Ns	RSPHSKR	Kepala Ruang IRNA 3B RSPH Sukorejo	
15	A. Kharimulloh Ikhwan, S.Kep.Ns	RSPHSKR	Kepala Ruang IRNA 3B RSPH Sukorejo	



RSPHSKR
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO, DESA LEMAHBANG KEC. SUKOREJO
KAB. PASURUAN
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Daftar Hadir
RAPAT PEMBAHASAN IMP-RS 2025

Tempat : ANDALUSIA
Location

Tanggal dan : Rabu, 2024-12-04 08:30:00
Jam Wed, 2024-12-04 08:30:00
Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
16	Ninis indrawati	RSPHSKR	Kepala Ruang Maternitas RSPH Sukorejo		
17	Ayu Mayang Priningtiyas, S.Kep., Ns	RSPHSKR	Kepala Ruang NICU RSPH Sukorejo		
18	Rhizqita Julian Eka R. Amd.PK.SKM	RSPHSKR	Kepala Unit Asuransi Center RSPH Sukorejo		
19	Dinnya Yesica Tandy	RSPHSKR	Komite PPI RSPH Sukorejo		
20	- LIDIA PUSPITA KENCANA, S.K.M.	RS Prima Husada Sukorejo	Mutu	LIDIA PUSPITA KENCANA	
21	Andrew Permadi Sugiarto	Laundry	Pelaksana		
22	Sinta Olivia Rahayu, S.Kep.Ns	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
23	Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.Ns	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
24	Aini Nur Rokhma, A.Md.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
25	Rizky Dwi Ramadhani , Amd.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
26	Hendi Wijayanto, S.Kep.,Ns	RS Prima Husada Malang	Perawat		
27	Aprilia Rose Mawati , A.Md.Kes	RS Prima Husada Sukorejo	Perekam Medis		
28	NOVI DWI HIDAYATI, S.Tr.Kes	pkrsphs	pkrs		
29	Erwan Saputra	RS Prima Husada Sukorejo	Security		

Malang, 04 Desember 2024

arindha.raihan@gmail.com

NOTULENSI

HARI / TANGGAL : RABU/ 04 DESEMBER 2024
 PUKUL : 08.30 WIB - SELESAI
 JENIS MEETING : KOORDINASI PENENTUAN INDIKATOR MUTU TAHUN 2025
 TEMPAT : RUANG ANDALUSIA LANTAI 3

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1.	Pokok Bahasan : Unit yang belum mengikuti Penentuan Indikator Mutu Tahun 2025 bersama Manajer Mutu dan Pelayanan PT Disa Prima Medika (Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP.) Masalah : Unit yang belum mengikuti penentuan Indikator Mutu Tahun 2025 bersama Manajer Mutu dan Pelayanan PT Disa Prima Medika: 1. Ponek 2. Radiologi 3. Laboratorium 4. Kesekretariatan 5. Driver 6. Pemulasaran Jenazah 7. ATEM-IPSRs 8. Cleaning Service 9. Gudang Umum 10. Humas & Marketing 11. MOD-MPP-PIPP 12. TB 13. Keuangan 14. HIV 15. KB 16. Stunting 17. IT-SIMRS Keterangan : - PIC : 1. Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns, M.Kep – Kabid Pelayanan 2. Dwi Novianti. A.Md.AK., S.Kes – Kabid Penunjang 3. Siti Maysaroh, Amd. Kep – Kabid Keperawatan 4. Restu Kurniawati – Kabid Umum & Keuangan 5. Robikatul Adawiyah, A.Md.Keb - PJ Ponek 6. M. Alif Yiza Mubarak, Amd.Rad. – Karu Radiologi 7. Elza Safarina Ulfa, Amd. AK – Karu Laboratorium 8. Arindha Rahma Putri, S. Psi – Sekretariat 9. Pangky Novel Matindas – Karu Driver 10. Achmad Syaichu – Pemulasaran Jenazah



	11. Suliyanto, Amd.Tekmed. – Karu ATEM-IPSRS 12. Bagus Ardiansyah – Karu Cleaning Service 13. Bella Altika Sari, S.Si – Gudang Umum 14. Lidia Emilinda, S.Tr.Keb., M.MRS – Humas & Marketing 15. Nuri Aini Izzah, S. Kep., Ns – MOD-MPP-PIPP 16. Irawati., Amd Kep – PJ Prognas TB 17. Anita Fitriasaki, S.E – Karu Keuangan 18. Vira Agustin Sintia Putri, A.Md.Kep – PJ Prognas HIV 19. Luhdy Rachmi, S.Keb Bd – PJ Prognas KB 20. Adinda Aulia Yuniar, S.Gz – PJ Prognas Gizi 21. Galih Satria Mahardika, S.Pd – Karu IT & SIMRS
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu unit untuk tahun 2025 akan ditentukan oleh Komite PMKP dan Manajemen
2	Pokok Bahasan : Indikator Mutu Prioritas Unit IGD
	Masalah : 1. Masih ditemukan SBAR dari IGD yang tidak lengkap 2. Pengisian pengkajian Medis E-rm belum maksimal 3. Pengisian pengkajian keperawatan E-rm belum maksimal 4. Pengisian Pengkajian Medis E-RM belum maksimal 5. Pengisian LOP antar shift banyak yang tidak lengkap 6. Pengisian Triage IGD banyak yang tidak lengkap 7. Seringnya gelang identitas pasien di IGD yang tidak terpasang sampai pasien di transfer di rawat inap 8. Adanya pendingan BPJS karena ketidaktepatan pemeriksaan dari Dokter IGD dengan DPJP Konsulan 9. Ditemukannya penempatan pasien di IGD yang tidak sesuai
	Keterangan : -
	PIC : 1. Aini Nur Rokhma, A.Md.Kep (PJ Mutu IGD) 2. Nurul Karima, A.Md.Kep (PIC Data Mutu IGD)
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di IGD yang belum tercapai tetap diikuti untuk Indikator Mutu di Tahun 2025 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif 3. Adapun pengajuan indikator mutu yang baru yakni: a. Kelengkapan pengisian LOP b. Kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD c. Waktu Tunggu Pemasangan Gelang Identitas pasien dari pasien mendaftar sampai terpasang di pasien < 15 menit (100%) d. Ketidaktepatan status klinis dengan DPJP konsulan (0%) e. Kepatuhan penempatan pasien di IGD (100%) 4. Adapun Indikator Mutu Unit IGD Tahun 2025 yang diajukan:



	a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) 3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4) Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%) 5) Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$) b. Indikator Mutu Prioritas RS: 1) Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR c. Indikator Mutu Unit: 1) Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat < 5 menit setelah pasien datang (100%) 2) Kematian pasien < 24 Jam ($\leq$ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)) 3) Kelengkapan pengisian pengkajian medis E-Rm (100%) 4) Kelengkapan pengisian pengkajian keperawatan E-Rm (100%) 5) Kelengkapan pengisian LOP (100%) 6) Kelengkapan form casemix bpjs (100%) 7) Kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD (100%) 8) Waktu Tunggu Pemasangan Gelang Identitas pasien dari pasien mendaftar sampai terpasang di pasien < 15 menit (100%) 9) Ketidaktepatan status klinis dengan DPJP konsulan (0%) 10) Kepatuhan penempatan pasien di IGD (100%)
3	Pokok Bahasan: Indikator Mutu IRNA 2A Masalah : 1. Terdapat Indikator Mutu Unit yang belum mencapai standar yakni : a. Kematian pasien < 48 jam tidak mencapai standar $\leq 0.24\%$ b. Kejadian pulang paksa masih banyak di IRNA 2A c. Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≥ 24 2. Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) di IRNA 2A hanya ada di Bulan April dan Bulan Agustus 2024 dikarenakan tidak ada pasien dengan diagnosa tunggal 3. Terdapat Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai Keterangan : - PIC : 1. Anis Purnamasari, Amd. Kep (PJ Mutu IRNA 2A) 2. Nisfil Fitria, Amd. Kep (PIC Data Mutu IRNA 2A) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di IRNA 2A yang belum tercapai tetap diikutkan untuk Indikator Mutu di Tahun 2025 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif 3. Adapun pengajuan indikator mutu yang baru yakni: a. Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai 4. Adapun Indikator Mutu Unit IRNA 2A Tahun 2025 yang diajukan:



	a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) 3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4) Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00 - 14.00 WIB) ($\geq 80\%$) 5) Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) ($\geq 80\%$) 6) Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%) 7) Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$) b. Indikator Mutu Prioritas RS: 1) Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR (100%) c. Indikator Mutu Unit IRNA 2A: 1) Kematian pasien < 48 jam ($\leq 0.24\%$) 2) Kejadian pulang paksa (0 kejadian) 3) Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai (0 kejadian) 4) Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≥ 24 Jam (100%) 5) Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat d. Indikator Mutu Isolasi: 1) Kepatuhan penggunaan APD di Ruang Isolasi staff dan keluarga (100%) 2) Kepatuhan kebersihan tangan di ruang isolasi (100%) 3) Kepatuhan pelepasan APD di ruang antero (100%) 4) Kepatuhan Penempatan pasien sesuai standar (100%)
4	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu IRNA 2B Masalah: 1. Terdapat Indikator Mutu Unit yang belum mencapai standar yakni : a. Kematian pasien < 48 jam belum mencapai standar $\leq 0.24\%$ b. Kejadian pulang paksa masih ada di IRNA 2B c. Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam 2. Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) di IRNA 2B tidak ada pasien dengan diagnosa tunggal 3. Terdapat Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai 4. Terdapat kejadian pasien kritis di IRNA 2B seperti pasien Hipoglikemi sehingga diperlukan <i>emergency respon time</i> (Waktu Tanggap Pelayanan Gawat Darurat) < 5 menit Keterangan :- PIC : 1. Bagas Surya Purwono, A.Md.Kep (PJ Mutu IRNA 2B) 2. Bagus Pamuji ., Amd Kep (PIC Data Mutu IRNA 2B) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di IRNA 2B yang belum tercapai tetap diikutkan untuk Indikator Mutu di Tahun 2025 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif



	3. Adapun pengajuan indikator mutu yang baru yakni: - Kejadian Kesalahan Pemberian Obat tidak sesuai antara isi dan E-tiket Pasien (0 kejadian) - Emergency Respon time < 5 menit (100%) 4. Adapun Indikator Mutu Unit IRNA 2B Tahun 2025 yang diajukan: - Indikator Mutu Nasional: - Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) - Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) - Kepatuhan identifikasi pasien (100%) - Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00 - 14.00 WIB) ($\geq 80\%$) - Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) ($\geq 80\%$) - Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%) - Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$) - Indikator Mutu Prioritas RS: - Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR (100%) - Indikator Mutu Unit IRNA 2B: - Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai (0 kejadian) - Kematian pasien < 48 jam ($\leq 0.24\%$) - Kejadian pulang paksa (0 kejadian) - Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≥ 24 Jam (100%) - Emergency Respon time < 5 menit (100%) - Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat (100%)
5	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu IRNA 3A Masalah : - Terdapat Indikator Mutu Unit yang belum mencapai standar yakni : - Kejadian pulang paksa masih ada di IRNA 2B - Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam - Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) di IRNA 3A, Penyakit Terbanyak ada di GEA dengan LOS rata-rata 4 hari, sedangkan pengisian di form LOS Standar 6 hari. - Terdapat Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai - Terdapat ketidaklengkapan pengisian Asesmen Nyeri di CPPT Asuhan Keperawatan Keterangan : PIC : - Sinta Olivia Rahayu., S.Kep Ns (PJ Mutu IRNA 3A) - Nadzifatul Khoiriyah, A.Md.Kep (PIC Data Mutu IRNA 3A) Rencana Tindak Lanjut : - Indikator mutu di IRNA 3A yang belum tercapai tetap diikutkan untuk Indikator Mutu di Tahun 2025 - Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif - Adapun pengajuan indikator mutu yang baru yakni: - Kejadian Kesalahan Pemberian Obat tidak sesuai antara isi dan E-tiket Pasien (0 kejadian)



	b. Kelengkapan Pengisian Asesmen Nyeri di CPPT Asuhan Keperawatan (100%) 4. Adapun Indikator Mutu Unit IRNA 3A Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) 3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4) Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00 - 14.00 WIB) ($\geq 80\%$) 5) Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) ($\geq 80\%$) 6) Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%) 7) Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$) b. Indikator Mutu Prioritas RS: 1) Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR (100%) c. Indikator Mutu Unit IRNA 3A: 1) Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai (0 kejadian) 2) Kelengkapan Pengisian Asesmen Nyeri di CPPT Asuhan Keperawatan (100%) 3) Kematian pasien < 48 jam ($\leq 0.24\%$) 4) Kejadian pulang paksa (0 kejadian) 5) Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≥ 24 Jam (100%) 6) Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat (100%)
6	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu IRNA 3B Masalah : 1. Terdapat Indikator Mutu Unit yang belum mencapai standar yakni : a. Kejadian pulang paksa masih ada b. Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam 2. Terkait Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) di IRNA 3B mulai Bulan Januari sampai Bulan September tidak ada pasien dengan diagnosa tunggal 3. Terdapat Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai 4. Ada beberapa dokter yang tulisannya tidak terbaca sehingga mempengaruhi kesalahan pemberian obat atau advice Keterangan : - PIC : 1. A. Kharimulloh I, S.Kep., Ns (PJ Mutu IRNA 3B) 2. Mariatul Rochmawati Nuris Wahyuni, S.Kep.,Ns (PIC Data Mutu IRNA 3B) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di IRNA 3B yang belum tercapai tetap diikuti untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun pengajuan indikator mutu yang baru yakni: a. Kejadian Kesalahan Pemberian Obat tidak sesuai antara isi dan E-tiket Pasien (0 kejadian) b. Kejadian Penulisan HFIS DPJP yang tidak bisa terbaca (0 kejadian)



	4. Adapun Indikator Mutu Unit IRNA 3B Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) 3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4) Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00 - 14.00 WIB) ($\geq 80\%$) 5) Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) ($\geq 80\%$) 6) Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%) 7) Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$) b. Indikator Mutu Prioritas RS: 1) Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR (100%) c. Indikator Mutu Unit IRNA 3B: 1) Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai (0 kejadian) 2) Kejadian Penulisan HFIS DPJP yang tidak bisa terbaca (0 kejadian) 3) Kematian pasien < 48 jam ($\leq 0.24\%$) 4) Kejadian pulang paksa (0 kejadian) 5) Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≥ 24 Jam (100%) 6) Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat (100%)
7	Pokok Bahasan : Indikator Mutu Maternitas Masalah : 1. Terdapat Pengajuan Indikator Mutu Klinis dari Dokter Hud Program QI AMP-SR Keterangan : - PIC : 1. Ninis Indrawati, S.Tr. Keb. (PJ Mutu Maternitas) 2. Karunia Rizqi Nurandini, S.Tr.Keb (PIC Data Mutu Maternitas) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di Maternitas yang belum tercapai tetap diikuti untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Unit Maternitas Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) 3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4) Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ≤ 30 mnt ($\geq 80\%$) 5) Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00 - 14.00 WIB) ($\geq 80\%$) 6) Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) ($\geq 80\%$) 7) Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%) 8) Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$) b. Indikator Mutu Prioritas RS:



	1) Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR (100%) c. Indikator Mutu Unit Maternitas: 1) Kepatuhan DPJP dalam penggunaan MgSO₄ pada pasien Pre eklamsi Berat/Eklamsi (100%) 2) Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat (100%) 3) Kejadian pasien Preeklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi (0 kejadian) 4) Kejadian pasien dengan kasus Preeklamsi berat aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam (0 kejadian) 5) Kejadian pasien dengan Eklamsia yang dilahirkan dalam waktu > 12 jam (0 kejadian) 6) Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB (0 kejadian) 7) Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh Eklampsia (0 kejadian) 8) Kepatuhan Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala III segera setelah bayi lahir (100%) 9) Kejadian kematian ibu karena HPP (0 kejadian) 10) Kejadian korioamnionitis pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini prematur ($\leq 1\%$) 11) Kepatuhan pemberian antibiotika profilaksis sebelum operasi SC < 1 jam (100%) 12) Kejadian kematian ibu persalinan karena sepsis (0 kejadian) 13) Persentase Ibu bersalin yang dilakukan skrining penilaian kegawatan/ severitas saat masuk ke Fasyankes (100%) 14) Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature (100%) 15) Kepatuhan Pemeriksaan DJJ saat kala II (100%) 16) Persentase Ibu hamil dengan anemia yang terjadi peningkatan kadar Hb setelah mendapatkan terapi medikamentosa (100%)
8	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Neonatologi Masalah : 1. Terdapat Pengajuan Indikator Mutu Klinis dari Dokter Hud Program QI AMP-SR Keterangan : - PIC : 1. Ayu Mayang Priningtiyas, S.Kep., Ns (PJ Mutu Neonatologi) 2. Higyanti Hijjah Rochmawati, S.Kep.,Ns (PIC Data Mutu Neonatologi) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di Neonatologi yang belum tercapai tetap diikuti untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Unit Neonatologi Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) 3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4) Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00 - 14.00 WIB) ($\geq 80\%$)



	5) Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) ($\geq 80\%$) 6) Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%) 7) Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$) b. Indikator Mutu Prioritas RS: 1) Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR (100%) c. Indikator Mutu Unit Neonatologi: 1) Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir (0 kejadian) 2) Kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan Ventilasi Tekanan positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit) (100%) 3) Persentase Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-piece resuscitator/CPAP dalam waktu 2 menit (100%) 4) Persentase Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500- 2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kanguru minimal 1 jam per hari (100%) 5) Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotik pada BBL infeksi (100%) 6) Kejadian kematian bayi di Rumah Sakit (0 kejadian) 7) Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr (100%)
9	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator IKO Masalah : 1. Terdapat 2 kali pasien yang terkena combustio saat operasi menggunakan couter di tahun 2024 yang menyebabkan komplain dari pasien 2. Terdapat pasien yang dipending pembayaran oleh BPJS dikarenakan ketidaklengkapan laporan operasi 3. Asesmen pra bedah sering tidak dilengkapi 4. DPJP jarang melakukan penandaan pasien operasi di asesmen nya 5. Pengisian surgical safety checklist diisi tidak sesuai standart 6. Indikator Mutu Prioritas RS tahun 2025 yakni Pelayanan Bedah Alasannya: 1) Berdasarkan 8 kriteria lembar kerja matrix prioritas perbaikan mutu RS tahun 2025 Yakni resiko tinggi, jumlah banyak, merupakan masalah bagi RS, kemudahan dalam pengukuran, hubungan dengan ketidakpuasan pasien, hubungan dengan ketentuan pemerintah, sesuai dengan tujuan strategi RS, memberikan pengalaman pasien lebih baik (<i>patient experience</i>) memiliki skor yang paling tinggi yakni 38 2) Terdapat 10 insiden KTD waktu kejadian operasi yang menyebabkan pasien komplain ke RS Prima Husada Sukorejo Keterangan : - PIC : 1. Rizky Dwi Ramadhani, Amd.Kep (PJ Mutu IKO) 2. Edo Fardiantoko, A.Md.Kep (PIC Data Mutu IKO Bedah) 3. Risky Rahmawan, S. Kep., Ns (PIC Data Mutu IKO Anestesi) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di IKO yang belum tercapai tetap diikutkan untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif.



3. Adapun Indikator Mutu Unit IKO Tahun 2025 yang diajukan:

a. Indikator Mutu Nasional:

- 1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$)
- 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%)
- 3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%)
- 4) Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit ($\leq 5\%$)
- 5) Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%)
- 6) Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$)

b. Indikator Mutu Prioritas RS: Pelayanan Bedah

- 1) Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP):
 - a) Kepatuhan Identifikasi pasien (100%)
 - b) Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR (100%)
 - c) Kepatuhan pengembalian obat sisa anestesi & narkotika ke ruang farmasi (100%)
 - d) Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist (100%)
 - e) Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi (0 kejadian)
 - f) Kepatuhan Kebersihan Tangan ($\geq 85\%$)
 - g) Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%)
- 2) Indikator Pelayanan Klinis Prioritas
 - a) Kejadian Kehamilan ektopik yang diduga apendiksitis (0 kejadian):
 - b) Kejadian ketidaksesuaian tindakan *soft tissue tumor* dengan narkose umum (0 kejadian)
- 3) Indikator sesuai Rencana Strategis RS:
 - a) Kepuasan pasien ($\geq 76.61\%$)
- 4) Indikator terkait Perbaikan Sistem:
 - a) Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi (0 kejadian)
 - b) Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO (100%)
 - c) Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi (100%)
- 5) Indikator terkait Manajemen Risiko:
 - a) Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran (0 kejadian)
 - b) Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal (100%)

c. Indikator Mutu Unit IKO Bedah:

- 1) Kepatuhan pembersihan ruang IKO antar jeda waktu operasi < 30 menit (100%)
- 2) Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari (100%)
- 3) Kejadian Kematian di meja Operasi (0 kejadian)
- 4) Kejadian operasi salah sisi (0 kejadian)
- 5) Kejadian operasi salah orang (0 kejadian)
- 6) Kejadian salah tindakan pada operasi (0 kejadian)
- 7) Kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi (0 kejadian)

d. Indikator Mutu Unit IKO Anestesi:

- 1) Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis ($\leq 6\%$)
- 2) Kejadian reaksi anestesi ($\leq 6\%$)
- 3) Kejadian salah penempatan ($\leq 6\%$)
- 4) Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi (0 kejadian)



	5) Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi (0 kejadian) 6) Angka efek samping selama sedasi moderat (0%) 7) Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi (0 kejadian) 8) Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi (0 kejadian)
10	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator IGD PONEK Masalah : 1. Terdapat kejadian kehamilan ektopik yang diduga apendiksitis Tahun 2024 2. Terdapat Insiden Pasien dengan diagnosa PEB tidak diberikan MgSO4 ketika di IGD dan baru diberikan di Ruang Maternitas yang menyebabkan keparahan kondisi pasien dan dirujuk ke RS Saiful Anwar 3. RS Prima Husada bergabung dalam QI Collaborative AMP-SR Keterangan : PIC : 1. Aini Nur Rokhma, A.Md.Kep (PJ Mutu IGD) 2. Robikatul Adawiyah, A.Md.Keb (PIC Data Mutu Ponek) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di Ponek yang belum tercapai tetap diikuti untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Unit Ponek Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) 3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4) Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt ($\geq 80\%$) 5) Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%) 6) Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$) b. Indikator Mutu Prioritas RS: 1) Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR (100%) 2) Kejadian Kehamilan ektopik yang diduga apendiksitis (100%) c. Indikator Mutu Unit Ponek: 1) Kepatuhan DPJP dalam penggunaan MgSO4 pada pasien Pre eklamsi Berat/Eklamsi (100%) 2) Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat (100%) 3) Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh Tim ponek yang terlatih (100%) 4) Persentase Ibu bersalin yang dilakukan skrining penilaian kegawatan/ severitas saat masuk ke Fasyankes (100%)
11	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Unit ICU



	Masalah : 1. Terkait kepuasan pasien di ruang ICU tidak diberlakukan dikarenakan kondisi pasien rata-rata di tahap terminal
	Keterangan : -
	PIC : 1. Debi Firmanasia, Amd. Kep (PJ Mutu ICU) 2. Lillo Palupi Armaidah, A.Md.Kep (PIC Data Mutu ICU)
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di ICU yang belum tercapai tetap diikutkan untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Unit ICU Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) 3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4) Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤ 14.00 WIB ($\geq 80\%$) 5) Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%) b. Indikator Mutu Prioritas RS: 1) Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR (100%) c. Indikator Mutu Unit ICU: 1) Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam ($\leq 3\%$) 2) Kepatuhan pengisian pengkajian form kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU (100%)
12	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu IRJA
	Masalah : 1. Belum ada perubahan warna di E-RM ketika SBAR an dari Dokter Konsulan sudah terkonfirmasi (Karu Pendaftaran dan RM Follow up ke Pak Dihin Programmer PT) 2. Masih banyaknya dokter poli yang terlambat di poli rawat jalan yang menyebabkan waktu tunggu rawat jalan lebih dari 1 jam
	Keterangan : -
	PIC : 1. Hendi Wijayanto, S.Kep., Ns (PJ Mutu IRJA) 2. Firdhausi Nuzula., Amd Kep (PIC Data Mutu IRJA)
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di IRJA yang belum tercapai tetap diikutkan untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Unit IRJA Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%)



	3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4) Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit ($\geq 80\%$) 5) Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$) 6) Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%) b. Indikator Mutu Prioritas RS: 1) Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR (100%) 2) Kejadian Kehamilan ektopik yang diduga apendiksitis (0 kejadian) c. Indikator Mutu Unit IRJA: 1) Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan ≥ 30 menit (0%) 2) Kelengkapan pengisian pengkajian awal medis E-RM pasien rawat jalan (100%) 3) Kelengkapan pengisian pengkajian awal keperawatan E-RM pasien rawat jalan (100%) 4) Kelengkapan Form E-RM PRMRJ Pasien (100%)
13	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu Rehab Medis Masalah :- Keterangan : - PIC : 1. Hendi Wijayanto, S.Kep., Ns (PJ Mutu Rehab Medik) 2. Rachmad Venus Andika, A.Md.Kes (PIC Data Mutu Rehab Medik) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di Rehab Medik yang belum tercapai tetap diikutkan untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Unit Rehab Medik Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) 3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4) Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh (100%) 5) Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$) b. Indikator Mutu Prioritas RS: 1) Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR (100%) c. Indikator Mutu Unit Rehab Medik: 1) Kejadian kesalahan Tindakan fisioterapi (0 kejadian) 2) Kelengkapan pengisian pengkajian medis & protocol pasien rehab medik (100%) 3) Kelengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik (100%) 4) Kepatuhan pengisian pengkajian reassesment setiap 2 minggu & akhir terapi (100%)
14	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu Farmasi Masalah : 1. Scan barcode kepuasan pasien belum bisa berjalan di Unit Farmasi



	2. Banyaknya sisa obat anestesi dari IKO yang belum dikembalikan ke Farmasi
	Keterangan : -
	PIC : 1. Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt (PJ Mutu Unit Farmasi) 2. Nabila Avliyatul Faizah, S.Farm.Apt (PIC Data Mutu Unit Farmasi)
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di Farmasi yang belum tercapai tetap diikuti untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Unit Farmasi Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) 3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4) Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$) 5) Penulisan resep sesuai formularium (100%) b. Indikator Mutu Prioritas RS: 1) Kepatuhan double check penyiapan obat high alert golongan sitostatika (IMP RS) c. Indikator Mutu Unit Farmasi: 1) Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit (100%) 2) Waktu tunggu pelayanan Obat Racikan ≤ 60 menit (100%) 3) Kejadian kesalahan pemberian obat (0 kejadian) 4) Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi (0 kejadian) 5) Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi (0 kejadian) 6) Kepatuhan pemusnahan sisa obat anestesi dari IKO (100%) 7) Kejadian perubahan pemberian obat profilaksis menjadi teraupetik (0 kejadian)
15	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu Gizi
	Masalah : 1. Belum tersedianya air panas dengan suhu 70 derajat Celsius di tempat cucian alat dapur
	Keterangan : -
	PIC : 1. Saila Nur Siti Khodijah, S. Gz.(PJ Mutu Unit Gizi) 2. Nathasya Arleta Dewi, S.Tr.Gz (PIC Data Mutu Unit Gizi)
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di Unit Gizi yang belum tercapai tetap diikuti untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Unit Gizi Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional:



	1) Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) 3) Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4) Kepuasan pasien ($\geq 76,61\%$) b. Indikator Mutu Unit Gizi: 1) Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien ($\geq 90\%$) 2) Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien ($\leq 20\%$) 3) Kejadian kesalahan pemberian diet (0 kejadian) 4) Angka kelengkapan pengisian asuhan gizi pasien rawat inap (100%) 5) Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien (0 kejadian) 6) Tersedianya air panas di tempat cucian alat dapur dengan standar 70 derajat (100%)
16	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu Rekam Medik Masalah : 1. SEP sering terjadi tidak diterbitkan Keterangan : - PIC : 1. Fina Fitriana Dwi Nur, Amd. RMIK (PJ Mutu Unit Rekam Medik) 2. Muhammad Suasana Iqbal Maulana, A.Md.Kes (PIC Mutu Unit Rekam Medik) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di Unit Rekam Medik yang belum tercapai tetap diikuti untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Unit Rekam Medik Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepuasan Pasien ($\geq 76,61\%$) b. Indikator Mutu Unit: 1) Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (100%) 2) Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas (100%) 3) Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda (0 kejadian) 4) Kejadian SEP tidak diterbitkan (0 kejadian) 5) Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl) (100%) 6) Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi $> 1 \times 24$ jam (0%) 7) Kelengkapan NIK di data pasien (100%) 8) Kelengkapan berkas E-RM Poli Klinik (100%) 9) Kelengkapan berkas E-RM IGD (100%) 10) Ketepatan laporan dengan pihak eksternal (100%)
17	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu Laundry



	Masalah : 1. Petugas sering tidak menggunakan handscoon dalam pengambilan linen kotor 2. Setiap bulan masih ditemukannya benda asing di linen 3. Dalam penyimpanan linen di unit rawat inap sering penataannya tidak rapi/kusut & spotting
	Keterangan : -
	PIC : 1. Ilham Eka Novianto Putro, A.Md.Kep (PJ Mutu CSSD & Laundry) 2. Andrew Permadi Sugiarto (PIC Data Mutu Laundry)
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di Unit Laundry yang belum tercapai tetap diikuti untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Unit Laundry Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan penggunaan APD (100%) b. Indikator Mutu Unit: 1) Kejadian linen yang hilang (0 kejadian) 2) Kejadian terdapat benda asing di linen (0 kejadian) 3) Ketepatan waktu pemeliharaan alat – alat pencucian linen (100%) 4) kejadian penataan linen di unit yang tidak rapi/kusut & spotting (0 kejadian)
18	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu CSSD Masalah : 1. Terdapat alat rusak sehingga mengubah ketetapan standar dalam indikator kertas steam 2. Resiko kerusakan mesin akibat cito yg terlalu sering 3. Ketidakpatuhan pemakaian gaun di CSSD Keterangan : - PIC : 1. Ilham Eka Novianto Putro, A.Md.Kep (PJ Mutu CSSD & Laundry) 2. Fernandika Bagus Setiawan (PIC Data Mutu CSSD) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di Unit CSSD yang belum tercapai tetap diikuti untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Unit CSSD Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Nasional: 1) Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan APD di area dekontaminasi (100%) b. Indikator Mutu Unit: 1) Kejadian kertas steam indikator tidak berubah sesuai standar (135 derajat) (0 kejadian) 2) Kepatuhan waktu pengembalian instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman (100%)



	3) Kepatuhan hasil biological test negative pada BMHP reuse: a) Breathing circuit b) Begging c) LMA d) JR 4) Kejadian tidak terpasangnya label LED pada instrumen (0 kejadian) 5) Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP (100%) 6) Kepatuhan petugas unit terkait penulisan serah terima alat pada buku sertir cssd baik bersih dan kotor (100%) 7) Kepatuhan unit dalam melakukan proses pengiriman dan pengambilan alat sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan CSSD (kecuali cito) (100%) 8) Kejadian tercampurnya benda tajam dengan instrumen kotor (0 kejadian)
19	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu Keamanan Masalah : 1. Banyaknya pelanggaran di jam berkunjung pasien tidak sesuai ketentuan 2. Banyaknya pasien yang kebingungan dalam petugas di unit karena petugas tidak memakai id card 3. Banyaknya pasien yang tidak menggunakan id card pengunjung ketika berkunjung di RS 4. Banyak ditemukannya pasien yang merokok di kawasan RS Keterangan : - PIC : 1. Erwan Saputra (PJ Mutu Keamanan) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di Keamanan yang belum tercapai tetap diikutkan untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Unit Keamanan Tahun 2025 yang diajukan: a. Indikator Mutu Unit: 1) Kejadian kehilangan barang milik pasien, pengunjung dan karyawan (0 kejadian) 2) Kepatuhan petugas keamanan melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift (100%) 3) Kepatuhan jam berkunjung sesuai dengan ketentuan (100%) 4) Kejadian kekerasan staf, pasien, & pengunjung di Rumah sakit (0 kejadian) 5) Kejadian merokok di Area Rumah Sakit (0 kejadian) 6) Kepatuhan penggunaan id card pengunjung di area rumah sakit (100%) 7) Kepatuhan penggunaan id card staff di area rumah sakit (100%)
20	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu PKRS Masalah :



	- Masih ditemukannya petugas yang tidak memberikan edukasi kelompok sesuai target yakni 8 kali dalam setiap bulan - Pasien jarang melakukan scan barcode pada leaflet sebagai media edukasi
	Keterangan : - PIC: - Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes (PJ Mutu PKRS) Rencana Tindak Lanjut : - Indikator mutu di PKRS yang belum tercapai tetap diikutkan untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. - Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. - Adapun Indikator Mutu PKRS Tahun 2025 yang diajukan: - Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok (100%) - Kepatuhan petugas dalam pengisian form edukasi kolaborasi (100%) - Ketepatan pengisian form edukasi terintegrasi (100%) - Kepatuhan staff dalam menggunakan media edukasi melalui elektronik (barcode leaflet) (100%) - Kepatuhan Komunikasi efektif terkait SBAR (CPPT, HO, rujuk internal, rujuk eksternal, konsultasi antar spesialis, pelaporan nilai kritis lab) (100%) - Kepatuhan pembinaan komunitas <u>berbasis RSPH (prognas dan geriatri)</u> (100%)
21	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu PPI Masalah : - Kepatuhan Kebersihan Tangan di Tahun 2024 tidak mencapai target $\geq 85\%$ - Kepatuhan APD di Tahun 2024 tidak mencapai target 100% - Banyaknya petugas yang tidak menggunakan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh - Setiap bulan masih ditemukannya petugas yang tidak memmmberikan edukasi kelompok terkait PPI - Terkait Mutu Phlebitis, CVC, VAP dan ISK sudah termasuk dalam Program PPI Keterangan : - PIC: - Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.,Ns (Komite PPI) Rencana Tindak Lanjut : - Indikator mutu di PPI yang belum tercapai tetap diikutkan untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. - Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. - Adapun Indikator Mutu PPI Tahun 2025 yang diajukan: - Indikator Mutu Nasional: - Kepatuhan Kebersihan Tangan ($\geq 85\%$) - Kepatuhan APD (100%) - Indikator Mutu Unit: - Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen (60%)



	2) Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter) (75%) 3) Angka infeksi daerah operasi ($\leq 1,5\%$) 4) Kepatuhan Penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi) (100%) 5) Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam (0 kejadian) 6) Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap (100%) 7) Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah) (100%) 8) Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN (100%) 9) Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh (100%) 10) Kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok terkait PPI (100%)
22	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu SDM Masalah : 1. Angka turn over tinggi 2. Kepuasan karyawan tidak mencapai standar 3. Masih ada kejadian SIP staff yang habis masa berlakunya 4. Penambahan staff tersertifikasi khusus yakni Hiperkes dan Hemodialisa 5. Banyaknya staff di bagian umum yang tidak mendapatkan pelatihan 20 JP dalam setahun Keterangan : - PIC: 1. Novia Ainur Pratiwi, S.KM (PJ Mutu SDM) 2. Rofi'atal Manzilah, S.Psi (PIC Data Mutu SDM) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di SDM yang belum tercapai tetap diikutkan untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu SDM Tahun 2025 yang diajukan: a. Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staff (100%) b. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 JP setahun ($\geq 60\%$) c. Angka turn over staff ($\leq 10\%$ / bulan) d. Kejadian SIP staff habis masa berlaku (0 kejadian) e. Angka keterlambatan staff ≥ 10 menit (0%) f. Angka staff tersertifikasi khusus (100%): 1) IGD : BLS/PPGD/GELS/ALS 2) Ponak : PPGD 3) ICU 4) HD 5) IKO 6) Hiperkes 7) NICU/PICU g. Kepuasan karyawan ($\geq 90\%$)

	h. Respon time penanganan masalah karyawan ≤ 24 jam (100%)
23	Pokok Bahasan : Penentuan Indikator Mutu Verifikator Masalah : 1. Banyak diagnosa yang tidak sesuai dengan ketentuan capaian 30% 2. Berkas penunjang klaim pelayanan ada yang tidak lengkap sebagai contoh radiologi yang tidak ada tidak hasil bacaan 3. E-RM triage IGD dijumpai tidak lengkap dikarenakan form fisik masih disediakan sehingga malas dalam membuka PC Keterangan : - PIC: 1. Aprilia Rose Mawati, A.Md.Kes (PJ Mutu Verifikator) 2. Putri Eka Pratiwi A.Md.RMIK (PIC Data Mutu Verifikator) Rencana Tindak Lanjut : 1. Indikator mutu di Verifikator yang belum tercapai tetap diikuti untuk Indikator Mutu di Tahun 2025. 2. Untuk mempermudah pengisian, nama Indikator Mutu di rubah menjadi kalimat positif. 3. Adapun Indikator Mutu Verifikator Tahun 2025 yang diajukan: a. kepatuhan DPJP dalam penegakan diagnosa sesuai dengan ketentuan BPJS (100%) b. kelengkapan berkas penunjang klaim pelayanan (100%) c. Kepatuhan petugas rawat inap terhadap penyetoran rekam medis BPJS Kesehatan < 24jam (100%) d. kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD (100%) e. Kepatuhan penerimaan hasil audit sesuai ketentuan BPJS (100%)



Pasuruan, 04 Desember 2024

Pemimpin Rapat

(Dr.dr. Aslichah M.Kes., AFP)

Notulis

(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)

Mengetahui,

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.



DOKUMENTASI

